

Zrozumieć *zaburzenie bliskiego*

Zaburzenia psychiczne to choroby — nie „słabość charakteru” ani „szukanie uwagi”. Zrozumienie tego zmniejsza wstyd i pomaga bliskiemu szukać leczenia.

CZAS: 10 min **POZIOM:** podstawowy **ŹRÓDŁO:** WHO (2022); Corrigan (2004)

JAK UŻYWAĆ

Karta pomaga zrozumieć, czym jest zaburzenie psychiczne — i czym nie jest. Najważniejszy przekaz: to choroba, jak cukrzyca czy astma, a nie wybór, lenistwo czy brak woli. Pokazuje, jak rzetelnie edukować się o zaburzeniu bliskiego i gdzie szukać wiarygodnych źródeł.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zaburzenia psychiczne to choroby, nie „wymysł”, „słabość charakteru” ani „szukanie uwagi”. Według WHO 1 na 8 osób na świecie żyje z zaburzeniem psychicznym — to powszechność, nie rzadkość. Stygmatyzacja jest główną barierą w szukaniu pomocy (Corrigan, 2004). Gdy bliscy moralizują („weź się w garść”), pacjent czuje wstyd i ukrywa objawy; gdy nadmiernie patologizują („jesteś chory/-a, nic nie potrafisz”) — odbierają mu sprawczość. Rzetelna edukacja zmniejsza wstyd po obu stronach.

01 Jak rzetelnie się edukować

1 • Sięgaj po wiarygodne źródła wytyczne kliniczne, materiały uznanych instytucji, nie przypadkowe fora.

2 • Czytaj rzetelne książki o konkretnym zaburzeniu bliskiego, najlepiej autorstwa klinicystów.

3 • Szukaj grup dla rodzin wsparcie i wiedza od osób w podobnej sytuacji.

4 • Pytaj klinicystę bliskiego za jego zgodą — to najlepsze źródło informacji o konkretnym przypadku.

**PULAPKA**

Dwa błędne ujęcia: moralizowanie („to lenistwo, brak charakteru”) — wywołuje wstyd i ukrywanie objawów; albo nadmierna patologizacja („jesteś chory/-a, nic nie potrafisz”) — odbiera bliskiemu poczucie sprawczości i nadziei.

CO POMAGA

Środek to ujęcie medyczne z zachowaniem podmiotowości: „masz chorobę, którą się leczy, i jesteś kimś więcej niż nią”. Choroba wyjaśnia objawy, ale nie definiuje całej osoby ani nie odbiera jej zdolności do zdrowienia.

**CO CHCĘ LEPIEJ ZROZUMIEĆ O ZABURZENIU BLISKIEGO**

— konkretne pytanie

Klucz: sposób, w jaki rozumiesz zaburzenie bliskiego, wpływa na to, jak go traktujesz — a to realnie oddziałuje na jego leczenie. Ujęcie „to choroba” (nie wina, nie wybór) zdejmuje wstyd, który jest największą barierą w szukaniu pomocy. Jednocześnie warto pamiętać, że bliski to *osoba z chorobą*, nie „chory” sprowadzony do diagnozy — zachowanie tej podmiotowości podtrzymuje nadzieję.

NARZĘDZIA POWIĄZANE Z TEGO MODUŁU

⊕ **Jak wspierać bliską osobę** — *zasady wsparcia*

⊕ **Psychoedukacja o zaburzeniach** — *pogłębiona wiedza dla bliskich*